

Mündliche Prüfungssimulation



20 Fallbeispiele im echten Prüfungsdialog – Prüferfrage, Musterantwort und komplette Pflegeplanung nach PESR und SMART.

Bestehen ist planbar.

Innere

Chirurgie

Neurologie

Onkologie

Urologie

Gynäkologie

HNO

Psychologie

20

Fallbeispiele

8

Fachbereiche

PESR

Pflegeplanung

INHALT

1

So übst du mit diesem Heft

2

Fallbeispiele nach Fachbereich

△ Lernhilfe zur Prüfungsvorbereitung. Musterantworten zeigen einen möglichen Lösungsweg – maßgeblich sind deine Lehrinhalte und die Anforderungen deiner Prüfer.

So übst du mit diesem Heft

Die mündliche Prüfung läuft fast immer gleich ab: Krankheitsbild, Symptome, Diagnostik und Therapie, Pflegeplanung.

1 · ZU ZWEIT ÜBEN

Eine Person liest die Prüferfrage vor, die andere antwortet frei. Danach mit der Musterantwort vergleichen.

2 · LAUT SPRECHEN

Antworte immer laut und in ganzen Sätzen. So trainierst du genau das, was in der Prüfung zählt.

3 · STRUKTUR NUTZEN

Definition → Symptome → Diagnostik/Therapie → Pflege. Diese Reihenfolge gibt dir Sicherheit.

4 · PESR ANWENDEN

Pflegeproblem: P = Problem · E = Einflussfaktoren · S = Symptome. Ressourcen immer mitnennen!

FALLBEISPIELE

01 Herzinsuffizienz · Innere Medizin

02 COPD · Innere Medizin

03 Diabetes mellitus Typ 2 · Innere Medizin

04 Hypertonie · Innere Medizin

05 Postoperative Pflege · Chirurgie & Orthopädie

06 Hüft-TEP / Knie-TEP · Chirurgie & Orthopädie

07 Appendizitis · Chirurgie & Orthopädie

08 Schlaganfall (Apoplex) · Neurologie

09 Epilepsie · Neurologie

10 Onkologische Pflegegrundlagen · Onkologie

11 Palliativpflege · Onkologie

12 Harnwegsinfekt (HWI) · Urologie

13 Benignes Prostataadenom (BPH) · Urologie

14 Mammakarzinom · Gynäkologie

15 Präeklampsie / Eklampsie · Gynäkologie

16 Tracheotomie-Pflege · HNO

17 Otitis media (Mittelohrentzündung) · HNO

18 Kommunikationsmodelle · Psychologie für Pflege

19 Stressbewältigung & Burnout · Psychologie für Pflege

20 Motivationstheorien · Psychologie für Pflege

INNERE MEDIZIN

1 Herzinsuffizienz ICD I50

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Herzinsuffizienz. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Unfähigkeit des Herzens, ausreichend Blut/Sauerstoff zu pumpen. Einteilung: Links-, Rechts- oder Globalinsuffizienz. NYHA-Stadien I–IV.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Dyspnoe (Belastung → Ruhe)
- Orthopnoe (flach liegen nicht möglich)
- Ödeme (Knöchel, Unterschenkel)
- Nykturie
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Zyanose
- Gewichtszunahme durch Wassereinlagerung
- Tachykardie

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Echo (EF < 40% = systolische HI)
- BNP/NT-proBNP erhöht
- Röntgen Thorax (Kardiomegalie, Lungenödem)
- EKG
- Labor: Kreatinin, Elektrolyte

THERAPIE

- ACE-Hemmer/Sartane
- Betablocker
- Diuretika (Furosemid)
- Aldosteronantagonisten
- Digoxin
- ICD/Resynchronisation

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigte kardiopulmonale Gewebepерfusion · E: verminderter Herzleistung · S: Dyspnoe, Zyanose, SpO ₂ < 94%
RESSOURCEN	Kooperativ, Versteht Anweisungen, Angehörige unterstützend
PFLEGEZIEL	Patient atmet in Ruhe ohne Dyspnoe (NRS Atemnot 0-2) innerhalb von 48h
MASSNAHMEN	• Oberkörperhochlagerung 30-45° kontinuierlich • O₂-Gabe nach Anordnung, SpO₂ ≥ 94% sichern • Vitalzeichen 4stündlich: RR, HF, AF, SpO₂ • Flüssigkeitsbilanz (Ein-/Ausfuhr täglich) • Tägliche Gewichtskontrolle (gleiche Zeit, Waage) • Ödeme dokumentieren (Umfang messen) • Aktivität schrittweise steigern nach Befinden
EVALUATION	Täglich: Dyspnoe-NRS, SpO ₂ , Gewicht, Ödeme

PFLEGEPROBLEM	P: Überschuss an Körperflüssigkeit · E: Herzpumpversagen · S: Ödeme, Gewichtszunahme 3kg/Woche
RESSOURCEN	Versteht Bedeutung der Trinkmengenbeschränkung
PFLEGEZIEL	Gewichtsreduktion um 0,5-1kg/Tag durch Diurese, Ödeme rückläufig nach 3 Tagen
MASSNAHMEN	• Trinkmengenbeschränkung nach Anordnung (meist 1,5-2L/Tag) • Diuretika pünktlich verabreichen, Wirkung dokumentieren • Natriumarme Ernährung besprechen • Hautpflege ödematöser Extremitäten (Druckgefahr!) • Hochlagerung der Beine • Patient über Selbstkontrolle schulen (Tagesgewicht)
EVALUATION	Täglich Gewicht, Bilanz, Ödemstatus

INNERE MEDIZIN
2 COPD ICD J44

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit COPD. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion durch chronische Bronchitis + Lungenemphysem. Hauptursache: Rauchen. GOLD-Stadien I–IV.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Chronischer Husten (Raucherhusten)
- Auswurf (morgens besonders)
- Belastungsdyspnoe (progredient)
- Giemen/Brummen
- Faszthorax (Emphysem)
- Lippenzyanose
- Uhrglasnägel
- Trommelschlägelfinger

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Spirometrie (FEV1/FVC < 0,7)
- Blutgasanalyse (BGA)
- Röntgen/CT Thorax
- 6-Minuten-Gehtest
- COPD-Assessment-Test (CAT)

THERAPIE

- Raucherentwöhnung (!)
- Bronchodilatoren (LABA, LAMA)
- Inhalatoren-Schulung
- Kortikosteroide inhalativ
- Atemphysiotherapie
- Langzeit-O₂ bei PaO₂ < 55mmHg

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Ineffektives Atemmuster · E: bronchialer Obstruktion · S: Dyspnoe NRS 6, AF 26/min, SpO ₂ 88%
RESSOURCEN	Kann Lippenbremse anwenden, Motiviert zur Mitarbeit
PFLEGEZIEL	SpO ₂ stabil bei 88–92 % (COPD-Zielbereich), Dyspnoe NRS ≤ 3 nach 24 h
MASSNAHMEN	• O₂-Gabe VORSICHTIG: Ziel SpO₂ 88-92% (nicht höher! Atemantriebreduktion!) • Kutschersitz anleiten (sitzend, Arme aufgestützt → Atemhilfsmuskulatur) • Lippenbremse üben und anwenden • Bronchodilatator-Inhalation nach Anordnung, Technik kontrollieren • Sekretmobilisation: atemunterstützende Lagerung, PEP-Geräte • Atemgymnastik 3x täglich • Körperliche Schonung, Aktivität nach Befinden
EVALUATION	4-stündlich SpO ₂ , AF, Dyspnoe-NRS

INNERE MEDIZIN

3 Diabetes mellitus Typ 2 ICD E11

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Chronische Stoffwechselerkrankung mit Insulinresistenz und relativem Insulinmangel. Häufigste Diabetesform (90%). Risikofaktoren: Adipositas, Bewegungsmangel, genetische Disposition.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Polyurie, Polydipsie (bei Entgleisung)
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Wundheilungsstörungen
- Häufige Infektionen
- Sehstörungen (Retinopathie)
- Kribbeln/Taubheit Füße (Neuropathie)
- Oft lange symptomlos!

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Nüchtern-BZ ≥ 126 mg/dl
- HbA1c $\geq 6,5\%$
- OGTT
- Urin: Mikroalbuminurie
- Augenhintergrund, Fußstatus

THERAPIE

- Basistherapie: Ernährung + Bewegung
- Metformin (First-Line)
- SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-RA
- Insulin (bei Versagen oraler Antidiabetika)
- HbA1c-Ziel individuell (meist $< 7\%$)

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko für Hypoglykämie · E: Insulintherapie und unregelmäßiger Nahrungsaufnahme
RESSOURCEN	Erkennt Hypoglykämie-Zeichen, Kann BZ selbst messen
PFLEGEZIEL	Keine Hypoglykämie-Episode (BZ > 70 mg/dl) während des stationären Aufenthalts
MASSNAHMEN	• BZ-Kontrolle nach Anordnung (nüchtern, vor/nach Mahlzeiten) • Mahlzeiten pünktlich, Insulin zeitgerecht verabreichen (6-R-Regel!) • Hypoglykämie-Schema beachten: BZ $< 70 \rightarrow 20$g KH oral (Traubenzucker) • BZ < 50 oder bewusstlos $\rightarrow$ Glukose 40% i.v. nach Anordnung • Notfallset: Glukose immer griffbereit • Schulung: Symptome Hypoglykämie (Zittern, Schwitzen, Herzrasen, Verwirrtheit)
EVALUATION	BZ-Profil täglich, Hypoglykämie-Ereignisse dokumentieren

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigte Gewebeintegrität · E: Wundheilungsstörung bei diabetischer Polyneuropathie · S: Ulcus plantare rechts
RESSOURCEN	Kooperativ, Familie unterstützt Verbandswechsel
PFLEGEZIEL	Wunde zeigt nach 7 Tagen Granulationsgewebe, keine Infektzeichen
MASSNAHMEN	• Tägliche Wundinspektion und Dokumentation (Foto, Maße, Exsudat, Geruch) • Verbandswechsel nach Wundexpertenstandard (feuchte Wundversorgung) • Druckentlastung: kein Druck auf Ulcus (Spezialschuhe, Bettung) • BZ-Einstellung optimieren (schlechte BZ → schlechte Wundheilung) • Fußpflege täglich: Inspektion alle Zehenzwischenräume • Fußwärme nicht mit Wärmflasche/Heizkissen! (Neuropathie = kein Temperaturempfinden)
EVALUATION	Täglich: Wunddokumentation, BZ-Verlauf

INNERE MEDIZIN
4 Hypertonie ICD I10

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Hypertonie. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Chronisch erhöhter Blutdruck $\geq 140/90$ mmHg. Häufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung. Meist primär (essentiell, 90%). Stiller Killer – oft jahrelang symptomlos.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Oft symptomlos!
- Kopfschmerzen (okzipital, morgens)
- Schwindel
- Ohrensausen
- Sehstörungen
- Hypertensive Krise: RR $> 180/120$ + Symptome

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Blutdruckmessung (mehrfach, beide Arme)
- 24h-Langzeit-RR
- EKG (LVH)
- Echo
- Labor: Kreatinin, Elektrolyte, Urin

THERAPIE

- Lebensstiländerung: Gewicht, Salz, Alkohol, Bewegung
- ACE-Hemmer/Sartane
- Kalziumantagonisten
- Betablocker
- Diuretika
- Ziel: $< 130/80$ mmHg

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Unzureichendes Selbstmanagement · E: Wissensmangel über Hypertonie · S: RR 175/105 trotz Medikation, unregelmäßige Einnahme
RESSOURCEN	Lernbereit, Möchte RR senken, Ehefrau unterstützt
PFLEGEZIEL	Patient nennt nach 3 Tagen 5 Maßnahmen zur RR-Senkung und nimmt Medikamente regelmäßig
MASSNAHMEN	• RR-Messung 2x täglich (morgens/abends, protokollieren) • Patientenedukation: Ursachen, Folgen, Therapieziel • Medikamenteneinnahme erklären: warum täglich, nicht absetzen! • Ernährungsberatung: Salzarm $< 6g/Tag$, Alkohol reduzieren • Gewichtskontrolle täglich • Bewegung: 30 Min./Tag moderate Aktivität • Stressreduktion besprechen
EVALUATION	Täglich RR-Protokoll, nach 3 Tagen Wissenstest Chirurgie & Orthopädie

CHIRURGIE & ORTHOPÄDIE
5 Postoperative Pflege ICD Z48

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Postoperative Pflege.“

Pflegerische Versorgung nach operativen Eingriffen. Ziel: Komplikationen verhindern, Erholung fördern, Selbstständigkeit wiederherstellen. ABCDE-Schema im AWR.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Schmerzen (NRS beachten!)
- Übelkeit/Erbrechen (PONV)
- Hypothermie
- Nachblutung
- Wundinfektion (ab Tag 3-5)
- Thrombose (ab Tag 1)
- Pneumonie (ab Tag 2-3)

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- Vitalzeichen-Monitoring
- Wundinspektion
- Drainageoutput
- Labor (BB, CRP, Gerinnung)
- Schmerzassessment NRS

MASSNAHMEN

- Schmerztherapie nach WHO-Schema
- Frühmobilisation!
- Thromboseprophylaxe
- Wundversorgung
- Ernährungsmanagement

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Akuter Schmerz · E: operativem Gewebetrauma · S: NRS 7/10, Patient schont sich, vermeidet Bewegung
RESSOURCEN	Kooperativ, Kann NRS-Skala anwenden, Versteht Bedeutung von Mobilisation trotz Schmerz
PFLEGEZIEL	Schmerzreduktion auf NRS ≤ 3 in Ruhe und NRS ≤ 5 bei Bewegung innerhalb von 2h nach Schmerzmedikation
MASSNAHMEN	• Schmerzerfassung NRS alle 4h + bei Bedarf • Analgetika nach Anordnung pünktlich (nicht erst bei NRS 8!) • Wirkung nach 30-60 Min. kontrollieren, dokumentieren • Lagerung: schmerzarme Position, Kissen zur Abstützung • Nicht-pharmakologisch: Kühlung, Ablenkung, Entspannung • Patienten zur Beurteilung von Schmerz vor Mobilisation einbeziehen • Arzt informieren bei NRS > 6 trotz Analgetikum
EVALUATION	NRS 30-60 Min. nach Medikation, täglich Schmerztagebuch

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko einer Wundinfektion · E: operativem Eingriff und Immunsuppression
RESSOURCEN	Versteht Hygienemaßnahmen, Kooperiert bei Verbandswechsel
PFLEGEZIEL	Keine Infektzeichen (Rötung, Schwellung, Eiter, Fieber > 38°C) bis zur Entlassung
MASSNAHMEN	• Verbandswechsel nach Standard, aseptisch • Wunddokumentation: Größe, Rand, Exsudat, Geruch, Temperatur • Vitalzeichen 2x täglich: Temperatur als Infektmarker • Labor: CRP, Leukozyten beachten • Drainagen: Menge, Farbe, Konsistenz täglich • Händehygiene bei jedem Wundkontakt • Patient: Wundzeichen erkennen, Selbstbeobachtung
EVALUATION	Täglich Wundinspektion, Temperatur, Labor

CHIRURGIE & ORTHOPÄDIE
6 Hüft-TEP / Knie-TEP ICD Z96.6

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Hüft-TEP / Knie-TEP. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Totalendoprothese der Hüfte (Hüft-TEP) oder des Knies (Knie-TEP). Häufigste elektive Orthopädie-Operation. Ziel: Schmerzfreiheit und Beweglichkeit wiederherstellen.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Postoperativ: Schmerzen, Schwellung
- Bewegungseinschränkung
- Luxationsgefahr (Hüft-TEP!)
- Thrombosegefahr

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Röntgen postoperativ
- Laborkontrollen
- Doppler bei TVT-Verdacht

THERAPIE

- Frühfunktionelle Behandlung
- Physiotherapie ab Tag 1
- Analgesie (PDA, Regionalanästhesie)
- Thromboseprophylaxe (NMH + Strümpfe)

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko der Hüft-TEP-Luxation · E: postoperativer Instabilität · S: Erstmobilisation Tag 1
RESSOURCEN	Versteht Luxationsprophylaxe, Kooperativ
PFLEGEZIEL	Keine Luxation während des stationären Aufenthalts, Patient kennt Verbotsspositionen nach Entlassung
MASSNAHMEN	• Verbotsspositionen einhalten: kein Beugen > 90°, kein Überkreuzen der Beine, kein Drehen des Fußes nach innen • Lagerungskeil zwischen die Beine (Abduktionskeil) • Transfer immer auf operierte Seite, Anleitung bei jedem Transfer • Toilettenerhöhung, erhöhte Sitzmöbel (Beugewinkel < 90°) • Patient und Angehörige in Verbotsspositionen schulen • Physio: Gangschulung mit Gehstützen
EVALUATION	Täglich Transfer kontrollieren, Patientenwissen überprüfen

CHIRURGIE & ORTHOPÄDIE
7 Appendizitis ICD K35

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Appendizitis. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Entzündung des Wurmfortsatzes (Appendix vermiformis). Häufigste chirurgische Notfallkrankung. Therapie: Appendektomie (laparoskopisch oder offen). Komplikation: Perforation!

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Schmerz: periumbilikal → rechter Unterbauch
- Übelkeit, Erbrechen
- McBurney-Punkt druckschmerzhaft
- Fieber 37,5-38,5°C
- Loslassschmerz (Blumberg-Zeichen)
- Abwehrspannung bei Perforation

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Klinische Untersuchung (Alvarado-Score)
- Labor: Leukozyten, CRP
- Sonographie
- CT bei Unklarheit

THERAPIE

- Appendektomie laparoskopisch (Standard)
- Antibiose perioperativ
- Bei Perforation: Drainage, Lavage

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Akuter Schmerz · E: entzündlichem Prozess/OP · S: NRS 8, Schonhaltung
RESSOURCEN	Jung, sonst gesund, Kooperativ
PFLEGEZIEL	NRS ≤ 3 in Ruhe nach 2h, NRS ≤ 5 bei Bewegung
MASSNAHMEN	• Analgetika nach Anordnung (kein Wärmepflaster auf Bauch!) • Schonlagerung: Knie leicht angewinkelt (Bauchdecke entspannt) • NRS alle 4h erheben • Kühlung auf Wunde wenn hilfreich • Bei Übelkeit: Antiemetikum nach Anordnung, Lagerung • Frühmobilisation nach OP trotz Schmerz anstreben
EVALUATION	NRS 30-60 Min. nach Analgetikum Neurologie

NEUROLOGIE

8 Schlaganfall (Apoplex) ICD I63 / I61

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Schlaganfall (Apoplex). Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Plötzliche fokale Hirnschädigung durch Ischämie (85%, I63) oder Blutung (15%, I61). Time is Brain: jede Minute = 1,9 Mio. Neuronenverluste. Thrombolyse-Fenster: 4,5h (ischämisch).

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Plötzliche einseitige Lähmung (Hemiparese/-plegie)
- Gesichtslähmung (faziale Parese)
- Sprach-/Sprechstörung (Aphasie/Dysarthrie)
- Schluckstörung (Dysphagie)
- Sehstörungen (Hemianopsie)
- Schwindel, Gangstörung
- Starke Kopfschmerzen (bei Blutung)
- Bewusstlosigkeit

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- FAST-Test (Prehospital)
- CT Schädel sofort (Blutung ausschließen!)
- MRT Schädel (diffusionsgewichtet)
- CT-/MR-Angiographie
- EKG (Vorhofflimmern?)
- Labor: Gerinnung, BZ

THERAPIE

- Stroke Unit!
- Ischämisch: Lyse rtPA i.v. (bis 4,5h) oder Thrombektomie (bis 24h)
- Blutung: neurochirurgisch ggf.
- Sekundärprophylaxe: ASS, Antikoagulation
- Frührehabilitation: Physio, Ergo, Logo ab Tag 1
- Dysphagie-Screening vor erstem Schluck!

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko Aspiration · E: Schluckstörung (Dysphagie) nach Schlaganfall · S: positives Dysphagie-Screening
RESSOURCEN	Patient kooperiert trotz Aphasie, Logopädie verfügbar
PFLEGEZIEL	Patient aspiriert nicht – sichere Nahrungsaufnahme durch angepasste Konsistenz nach logopädischer Freigabe
MASSNAHMEN	• Vor ERSTEM Schluck: standardisiertes Dysphagie-Screening (z.B. 3-Unzen-Wassertest) • Bis Screening-Ergebnis: NICHTS per oral, Mund feucht halten • Nach Logo-Freigabe: angepasste Kost (Andickungsmittel, weiche Kost) • Beim Essen: aufrechte Position 90°, betroffene Seite unterstützen • Essen nie überstürzen, genug Zeit lassen • Absauggerät bereithalten • Nach Essen 30 Min. aufrecht bleiben • Angehörige in sicheres Füttern schulen
EVALUATION	Täglich Schluckfähigkeit beobachten, Aspirationszeichen (Husten, Stimmveränderung)

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigte körperliche Mobilität · E: Hemiparese links · S: Patient kann linken Arm/Bein nicht heben
RESSOURCEN	Hohe Motivation, Vorhandenes Pflegebett mit Hilfsmitteln
PFLEGEZIEL	Patient dreht sich mit geringer Hilfe auf betroffene Seite nach 3 Tagen Frührehabilitation
MASSNAHMEN	• Bobath-Lagerung: betroffene Seite einbeziehen, nicht kompensieren • Stundenlageplan: alle 2h Umlagerung • Patient von betroffener Seite ansprechen (Förderung Aufmerksamkeit zur Seite) • Frührehabilitation: Physiotherapie ab Tag 1 nach Anordnung • Transfertraining (Bett → Stuhl) mit PT • Hilfsmittel: Rollator, Handschiene nach Ergotherapie • Antispastik-Lagerung beachten (Armschiene)
EVALUATION	Täglich Motorik, Tonus, Lagerungstoleranz

NEUROLOGIE
9 Epilepsie ICD G40

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Epilepsie. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Chronische Erkrankung mit rezidivierenden epileptischen Anfällen durch unkontrollierte synchrone Entladungen von Neuronenverbänden. Prävalenz: 0,5-1%. Fokal oder generalisiert. Status epilepticus: Anfall > 5 Min. = Notfall.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Tonisch-klonischer Anfall (grand mal)
- Absence (kurze Bewusstseinsunterbrechung)
- Aura (subjektive Vorboten)
- Myoklonien
- Postiktale Phase: Verwirrtheit, Erschöpfung
- Status epilepticus: Anfall > 5 Min.

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- EEG (interiktal/iktal)
- MRT Schädel
- Labor: BZ, Elektrolyte, Antiepileptika-Spiegel
- Provokationsfaktoren erfragen

THERAPIE

- Antiepileptika: Valproat, Lamotrigin, Levetiracetam, Carbamazepin
- Status epilepticus: Lorazepam i.v. → Phenytoin → Narkose
- Anfallsauslöser vermeiden (Schlafentzug, Alkohol, Flackerlicht)
- Führerschein: 12 Monate anfallsfrei

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko sturzbedingte Verletzung · E: unkontrollierten Krampfanfällen · S: Epilepsie, letzter Anfall vor 3 Tagen
RESSOURCEN	Versteht Sicherheitsmaßnahmen, Kooperativ
PFLEGEZIEL	Patient verletzt sich bei möglichem Anfall nicht durch konsequente Sturzprophylaxe
MASSNAHMEN	• Bettgitter tagsüber nur nach Risiko-Assessment – nicht pauschal! • Scharfe Gegenstände aus Griffweite entfernen • Bett auf niedrigste Position • Bei Anfall: NIEMALS festhalten, Atemweg freihalten, Zeit stoppen • Kein Beißkeil! (Verletzungsgefahr, Aspiration) • Patienten NICHT alleine lassen während Anfall • Nach Anfall: stabile Seitenlage, Sauerstoff, Vitalzeichen • Anfall dokumentieren: Beginn, Dauer, Verlauf, postiktale Phase
EVALUATION	Bei jedem Anfall: Dauer, Art, Verlauf dokumentieren Onkologie

ONKOLOGIE

10 Onkologische Pflegegrundlagen ICD C00-C97

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Onkologische Pflegegrundlagen.“

Onkologische Pflege umfasst alle pflegerischen Maßnahmen bei Krebserkrankungen: Prävention, Therapiebegleitung (OP, Chemo, Bestrahlung, Immuntherapie), Symptommanagement und Palliativpflege. Besondere Anforderungen an Kommunikation und Psychoonkologie.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- B-Symptome: Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust
- Fatigue (tumorbedingte Erschöpfung)
- Schmerzen (akut/chronisch)
- Nausea/Emesis (CINV)
- Mukositis (Schleimhautentzündung)
- Neutropenie (Infektionsgefahr)
- Thrombozytopenie (Blutungsrisiko)
- Alopecie (Haarausfall)

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- Staging: TNM-Klassifikation
- PET-CT, CT, MRT
- Tumormarker
- Biopsie
- Labor: Blutbild, Leber/Niere vor Chemo

MASSNAHMEN

- Chirurgie
- Chemotherapie (Zytostatika)
- Strahlentherapie
- Immuntherapie (Checkpoint-Inhibitoren)
- Targeted Therapy (Tyrosinkinasehemmer)
- Palliativtherapie

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Übelkeit und Erbrechen · E: Chemotherapie (CINV) · S: Patient erbricht 5x täglich, Nahrungsablehnung
RESSOURCEN	Antiemetika vorhanden, Familie unterstützend, Motivation trotz Erschöpfung
PFLEGEZIEL	CINV auf max. 2 Erbrechen/Tag reduziert, ausreichende Flüssigkeitszufuhr gesichert nach 48h
MASSNAHMEN	• Antiemetika nach Schema: prophylaktisch VOR Chemo-Gabe! • 5-HT3-Antagonisten (Ondansetron) + Dexamethason + NK1-Antagonisten (Aprepitant) je nach Emetogenität • Kalte/kühle Speisen bevorzugen (weniger Geruch) • Kleine, häufige Mahlzeiten (5-6/Tag statt 3 große) • Stark riechende Speisen vermeiden • Frische Luft, Fenster öffnen • Ingwer-Tee, Pfefferminze • Flüssigkeitsbilanz führen, bei > 1L Defizit: i.v.-Hydratation • Mundpflege nach Erbrechen (Mundspülung)
EVALUATION	Emesis-Tagebuch: Häufigkeit, Schwere (NCI-Skala)

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko Infektion · E: Neutropenie durch Chemotherapie · S: Leukozyten 0,8 G/L, Fieber 38,5°C
RESSOURCEN	Patient kennt Infektionszeichen, Isolierungsmöglichkeit vorhanden
PFLEGEZIEL	Keine lebensbedrohliche Infektion durch konsequente Schutzmaßnahmen; bei febriler Neutropenie: Antibiose innerhalb 1h
MASSNAHMEN	• Febrile Neutropenie = Notfall: Fieber $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$ bei Neutrophilen $< 500/\mu\text{l}$ → sofort Arzt! • Blutkultur (2 Paare) VOR Antibiose (nicht verzögern!) • Breitband-Antibiose innerhalb 1h nach Anordnung • Umkehrisolation (protektive Isolation): Besucher mit MNS • Händehygiene: strikt WHO 5 Momente • Keine frischen Blumen/Topfpflanzen im Zimmer (Schimmel!) • Keine Rohkost, kein Rohmilchkäse (Low-Microbial-Diät nach Standard) • Täglich: Mundpflege Chlorhexidin, Körperpflege • GCSF nach Anordnung (Wachstumsfaktor für Neutrophile)
EVALUATION	4-stündlich Temperatur, täglich Leukozyten/Neutrophile

ONKOLOGIE
11 Palliativpflege ICD Z51.5

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Palliativpflege.“

Palliativpflege = aktive Gesamtbehandlung von Patienten mit unheilbarer, fortgeschrittener Erkrankung. Ziel: Lebensqualität, nicht Lebenszeit. WHO-Definition: weder Lebensverkürzung noch -verlängerung. Umfasst Schmerztherapie, Symptomkontrolle, psychosoziale/spirituelle Unterstützung.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Schmerzen (häufig unzureichend behandelt)
- Mundtrockenheit
- Dyspnoe
- Angst, Depression
- Übelkeit
- Delir (terminal)
- Obstipation (durch Opioide)
- Rasselatmung (Sterbephase)

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- ECOG/KPS (Performance Status)
- ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale)
- Schmerzassessment: NRS, BPI
- Spirituelle Bedürfnisse: SPIR-Interview

MASSNAHMEN

- Analgesie WHO-Stufenschema
- Opioide: Morphin, Oxycodon, Fentanyl transdermal
- Symptomkontrolle: Antiemetika, Laxanzien obligat zu Opioiden!
- Psychosoziale Unterstützung
- Seelsorge
- Angehörigenbegleitung

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Chronischer Schmerz · E: Tumorprogress · S: NRS 7 in Ruhe, Patient schläft nicht
RESSOURCEN	Offen für Opioidtherapie, Angehörige unterstützen Pflege
PFLEGEZIEL	Dauerschmerz NRS ≤ 3, Nachtschlaf ≥ 5h nach Opioideinstellung innerhalb 48h
MASSNAHMEN	• Schmerzassessment: NRS, Lokalisation, Qualität, Verstärker/Linderung • Retardiertes Opioid nach Anordnung zur festen Zeit (nicht nach Bedarf!) • Schnellwirkendes Opioid als Reserve bei Durchbruchschmerz bereithalten • Laxans immer gleichzeitig zu Opioid verordnen lassen (keine Obstipation!) • Schmerztagebuch führen (Patient einbeziehen) • Komplementäre Maßnahmen: Lagerung, Wärme/Kälte, TENS, Entspannung • Nichts erzwingen: Patient darf Therapie ablehnen • Angehörige in Schmerzbeobachtung schulen
EVALUATION	NRS 4-stündlich, Schlafqualität täglich, Nebenwirkungen (Obstipation, Übelkeit, Sedierung) Urologie

UROLOGIE

12 Harnwegsinfekt (HWI) ICD N39.0

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Harnwegsinfekt (HWI). Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Häufigste bakterielle Infektion. Unkompliziert: Zystitis (Blase). Kompliziert: Pyelonephritis (Niere), katheterassoziiert (CAUTI). Häufigster Erreger: E. coli (80%). Frauen 10× häufiger betroffen.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Dysurie (Brennen beim Wasserlassen)
- Pollakisurie (häufiger Harndrang)
- Hämaturie
- Übelriechender/trüber Urin
- Unterbauchschmerzen/-druck
- Bei Pyelonephritis: Fieber, Flanken-/Klopfschmerz
- Verwirrtheit (bei alten Menschen oft einziges Zeichen!)

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Urinstreifentest (Nitrit, Leukozyten)
- Urinstatus + Kultur (Mittelstrahlurin!)
- Blutbild, CRP
- Sonographie Nieren bei Pyelonephritis
- Blutkultur bei Sepsisverdacht

THERAPIE

- Unkompliziert: Nitrofurantoin, Fosfomycin, Trimethoprim
- Pyelonephritis: Fluorochinolone, Cephalosporine i.v.
- Katheter-HWI: Antibiose + Katheterwechsel
- Viel trinken (2-3L/Tag)
- Wärme (Wärmflasche Unterbauch)

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko katheterassoziiierter Harnwegsinfektion · E: liegendem DK · S: Immunsuppression
RESSOURCEN	Kooperativer Patient, Pflegepersonal geschult
PFLEGEZIEL	Patient entwickelt keine Katheterinfektion (kein Fieber, kein Urin-Befund) über Liegedauer
MASSNAHMEN	• Tägliche Indikationsprüfung: DK wirklich nötig? → frühzeitig entfernen! • Sterile Anlage, geschlossenes System immer erhalten • Intimhygiene 2x täglich mit Wasser (kein Desinfektionsmittel!) • Beutel immer unter Blasenniveau, niemals auf Boden • Kein Abklemmen des Katheters • Auf Katheterstau/Knick achten • Flüssigkeitszufuhr 1,5-2L/Tag sichern • Täglich: Urin beurteilen (Trübung, Geruch, Farbe)
EVALUATION	Täglich Urinbeschaffenheit, Temperatur, Befinden

UROLOGIE

13 Benignes Prostataadenom (BPH) ICD N40

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Benignes Prostataadenom (BPH). Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Gutartige Vergrößerung der Prostata. Betrifft 50% der Männer >50J, 90% der >80-Jährigen. Führt zu Blasausflussobstruktion mit LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). Kein Krebsrisiko per se.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Abschwächung des Harnstrahls
- Harnstottern (intermittierender Strahl)
- Restharngefühl
- Nykturie (nächtliches Wasserlassen)
- Pollakisurie
- Harndrang
- Harnverhalt (akut)

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- IPSS-Score (International Prostate Symptom Score)
- PSA-Wert
- Sonographie (Prostatavolumen, Restharn)
- Urodynamik
- Uroflowmetrie
- Rektale Untersuchung

THERAPIE

- Medikamentös: Alpha-1-Blocker (Tamsulosin), 5-Alpha-Reduktasehemmer
- Operative Entfernung: TURP (transurethrale Resektion)
- Laser-Verfahren
- Notfall Harnverhalt: transurethraler Katheter

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Akuter Harnverhalt · E: BPH · S: Restharn 600ml, starker Harndrang, Unterbauchschmerzen
RESSOURCEN	Kooperativer Patient, Schmerzmittel vorhanden
PFLEGEZIEL	Blasenentlastung durch Katheteranlage innerhalb 30 Min., Schmerzfreiheit
MASSNAHMEN	• Transurethralen Katheter nach ärztl. Anordnung anlegen (aseptisch!) • Urin langsam ablassen: nicht mehr als 500ml auf einmal (Hypotension, Hämaturie vermeiden) • Urinmenge, -farbe, -geruch dokumentieren • Schmerzerfassung (NRS) vor und nach Katheteranlage • Wärme auf Unterbauch (prä-/periinterventionell) • Aufklärung über TURP wenn geplant • Sturzprophylaxe: Drang → Stürze bei Eile
EVALUATION	Restharnkontrolle nach Miktion (Sonographie), Schmerz-NRS Gynäkologie

GYNÄKOLOGIE

14 Mammakarzinom ICD C50

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Mammakarzinom. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Häufigste Krebserkrankung der Frau (30% aller Karzinome). Invasives duktales oder lobuläres Karzinom. Risikofaktoren: BRCA1/2, Alter, Hormone, Adipositas. 5-Jahres-Überleben Stad. I: >95%.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Schmerzlose Verhärtung der Brust
- Axilläre Lymphknotenschwellung
- Hautveränderungen (Orangenhaut, Einziehungen)
- Asymmetrie der Brust
- Brustwarzeneinziehung oder -ausfluss
- Hautrötung/Überwärmung (inflammatorisch)

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Mammographie (Screening ab 50)
- Sonographie
- MRT Mamma
- Stanzbiopsie (Histologie)
- Sentinel-Lymphknoten-Biopsie
- Staging: CT, Knochenszintigraphie

THERAPIE

- Operation: BET (brusterhaltend) oder Mastektomie
- Sentinel-LK-Biopsie / Axilladisektion
- Strahlentherapie nach BET
- Chemotherapie (neo-/adjuvant)
- Antihormontherapie (Tamoxifen, Aromatasehemmer)
- Herceptin bei HER2-positiv

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigtes Körperbild · E: Mastektomie/Narbe · S: Patientin betrachtet Wunde nicht, äußert Scham
RESSOURCEN	Vertrauensvolle Beziehung zur Pflegekraft, Unterstützender Partner, Offenheit für Gespräche
PFLEGEZIEL	Patientin betrachtet Wundbereich und benennt 2 positive Aspekte ihres Körpers bis zur Entlassung
MASSNAHMEN	• Einfühlsame Wundpflege: Patientin einbeziehen, nicht drängen • Aktives Zuhören: Gefühle ernst nehmen, nicht bagatellisieren • Informationen über Brustprothesen, Rekonstruktion anbieten • Kontakt zu Selbsthilfegruppe (z.B. Frauenselbsthilfe nach Krebs) • Sexualberatung bei Bedarf ansprechen • Psychoonkologischen Dienst einbeziehen
EVALUATION	Täglich Gesprächsbereitschaft beobachten, Körperbildwahrnehmung erfragen

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko Lymphödem · E: Axilladisektion · S: Einschränkung Lymphabfluss rechter Arm
RESSOURCEN	Versteht Prophylaxemaßnahmen, Kooperativ
PFLEGEZIEL	Patientin benennt Lymphödem-Prophylaxemaßnahmen korrekt vor Entlassung
MASSNAHMEN	• Keine Blutdruck-Messungen, Injektionen, Blutabnahmen am betroffenen Arm • Armlymphödem-Prophylaxe schulen: kein enger Schmuck, keine Hitze • Manuelle Lymphdrainage nach Anordnung • Kompressionshandschuh/ärmel anpassen • Auf Infektionszeichen achten (Rötung, Schwellung, Wärme) • Arm bei Ruhe hochlagern
EVALUATION	Armumfang täglich messen, Ödem dokumentieren

GYNÄKOLOGIE
15 Präeklampsie / Eklampsie ICD O14

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Präeklampsie / Eklampsie. Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Hypertensive Schwangerschaftserkrankung ab 20. SSW. Präeklampsie: RR $\geq 140/90$ + Proteinurie. Schwere Form: HELLP-Syndrom. Eklampsie: zerebrale Krampfanfälle. Lebensbedrohlich für Mutter und Kind.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- RR $\geq 140/90$ mmHg nach 20. SSW
- Proteinurie $> 0,3\text{g}/24\text{h}$
- Ödeme (Gesicht, Hände)
- Kopfschmerzen
- Sehstörungen, Flimmern
- Oberbauchschmerzen (HELLP)
- Übelkeit, Erbrechen
- Hyperreflexie

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- RR-Messung (mehrfach)
- Proteinurie (Streifentest, 24h-Urin)
- Labor: Thrombozyten, Transaminasen, LDH, Harnsäure
- CTG, Doppler-Sonographie
- Augenhintergrund

THERAPIE

- Stationäre Überwachung
- Antihypertensiva: Methyldopa, Nifedipin, Labetalol
- Magnesium i.v. (Eklampsie-Prophylaxe!)
- Bei Eklampsie: Diazepam, Sicherung Atemweg
- Entbindung = einzige Heilung
- Frühgeburt einkalkulieren

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko mütterlicher Verletzung · E: möglichem Eklampsie-Anfall · S: RR 160/100, Hyperreflexie
RESSOURCEN	Hospitalisiert, CTG-Monitoring vorhanden, Kooperative Patientin
PFLEGEZIEL	Patientin erleidet keinen Krampfanfall durch konsequente Prophylaxe und Überwachung
MASSNAHMEN	• RR alle 15-30 Min. messen und dokumentieren • Magnesium i.v. nach Anordnung: Laufrate kontrollieren • Patellarsehnenreflex stündlich prüfen (Mg-Toxizität!) • Atemfrequenz überwachen ($> 12/\text{Min.}$!) • Antidot Calciumgluconat griffbereit halten • Reizarme Umgebung: Licht dimmen, Ruhe • Sturzprophylaxe: Bettgitter hochstellen • Krampfbereitschaft: Beißkeil, Sauger, O₂ bereit
EVALUATION	Kontinuierliches Monitoring, sofort Arzt bei RR $> 160/110$ oder Reflexveränderungen HNO

HNO
16 Tracheotomie-Pflege ICD Z93.0

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Tracheotomie-Pflege.“

Tracheotomie = operativer Zugang zur Trachea. Temporär (PDT: perkutane Dilatationstracheotomie bei Langzeitbeatmung) oder dauerhaft (Laryngektomie). Sichert Atemweg, erleichtert Weaning. Tracheostomaversorgung ist Kernkompetenz der Intensivpflege und HNO.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Atemnot bei Verlegung der Kanüle
- Sekretansammlung
- Hautreizung um Stoma
- Granulationen
- Kanülenobstruktion

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- Klinische Beurteilung (Atemgeräusche, Sekret)
- Laryngoskopie bei Komplikationen
- Bronchoskopie bei Verdacht Sekretpfropf

MASSNAHMEN

- Regelmäßige Kanülenpflege
- Absaugung (steril/aseptisch nach Standard)
- Innenkanüle wechseln
- Feuchtigkeitserhalt (HME-Filter, Befeuchtung)
- Stoma-Hautpflege
- Sprechen: Sprechkanüle, Passy-Muir-Ventil

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Ineffektive Atemwegsclearance · E: Tracheotomie und eingeschränktem Hustenmechanismus · S: zähes Sekret, Absaugbedarf
RESSOURCEN	Patient kann bei Absaugung mitarbeiten, Absaugeinheit vorhanden
PFLEGEZIEL	Atemwege bleiben frei, SpO ₂ ≥ 94%, Absaugintervall > 2h ohne Atemnot
MASSNAHMEN	• Absaugung: NUR bei Bedarf (nicht nach Schema!), sterile Technik • Vor Absaugen: präoxygenieren (FiO₂ erhöhen, bei Beatmung) • Einführtiefe: max. 0,5cm über Kanülenspitze – nicht tiefer! • Sog max. 150-200 cmH₂O, max. 15 Sek. pro Absaugvorgang • Innenkanüle alle 8h wechseln/reinigen • HME-Filter 24h-Wechsel (Befeuchtung, Bakterienfilter) • Ausreichend Flüssigkeit sichern (Sekretverflüssigung) • Raumluftbefeuchtung • Stoma täglich reinigen: sterile NaCl-Kompressen
EVALUATION	Atemgeräusche, SpO ₂ , Sekretmenge/-beschaffenheit, Hautbefund

HNO

17 Otitis media (Mittelohrentzündung) ICD H66

Prüfer: „Stellen Sie sich vor, Sie betreuen einen Patienten mit Otitis media (Mittelohrentzündung). Erklären Sie kurz das Krankheitsbild.“

Häufigste bakterielle Infektion im Kindesalter (70% aller Kinder bis 3J. mindestens einmal). Akut: meist viral/ bakteriell (Pneumokokken, H. influenzae). Chronisch: Gefahr Komplikationen. Wichtig für GPA-PädiatrieEinsatz.

Prüfer: „Welche Symptome würden Sie beobachten?“

- Starke Ohrenscherzen (Otalgie)
- Ohrziehen (Kinder)
- Fieber
- Druckgefühl im Ohr
- Hörverlust (Schallleitungsschwerhörigkeit)
- Eitrige Sekretion bei Perforation (dann Schmerzlinderung!)
- Reizbarkeit (Säuglinge)

Prüfer: „Welche Diagnostik und Therapie erwarten Sie?“

DIAGNOSTIK

- Otoskopie: gerötet, vorgewölbt, Lichtreflex fehlt
- Tympanometrie
- Audiometrie bei chronischer Form
- Abstrich bei Sekretion

THERAPIE

- Schmerztherapie: Ibuprofen, Paracetamol
- Abschwellende Nasentropfen
- Abwartend bei unkomplizierter akuter Otitis (7 Tage)
- Antibiotika: Amoxicillin bei Komplikationen/ Risikogruppen
- Parazentese (Einschnitt Trommelfell) bei starken Schmerzen
- Paukenröhrchen bei rezidivierender Otitis

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Akuter Schmerz · E: Mittelohrentzündung · S: Kind weint, NRS-Kinderskala 7, Ohrziehen
RESSOURCEN	Eltern kooperativ, Kind ablenkbar
PFLEGEZIEL	Schmerz auf NRS-Kinderskala ≤ 3 innerhalb von 1h nach Analgesie
MASSNAHMEN	• Analgetikum nach Anordnung: Ibuprofen (bevorzugt, auch antiinflammatorisch) oder Paracetamol gewichtsadaptiert • Wärme auf Ohr (Kirschkernsäckchen, wenn kein Abszess!) • Abschwellende Nasentropfen nach Anordnung • Ablenkung: Spielzeug, Eltern einbeziehen • Keine Wattepfropfen ins Ohr! • Lagerung: betroffene Seite oben → erleichtert Drainage • Fiebersenkung nach Anordnung
EVALUATION	NRS-Kinderskala 30 Min. nach Analgesie Psychologie für Pflege

PSYCHOLOGIE FÜR PFLEGE

18 Kommunikationsmodelle

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Kommunikationsmodelle.“

Theoretische Modelle zur Erklärung von Kommunikationsprozessen. In der Pflege grundlegend für therapeutische Kommunikation, Patientenedukation und Teamarbeit.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Kommunikationsprobleme
- Konflikte im Team
- Missverständnisse
- Non-Compliance des Patienten

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“

INSTRUMENTE

- Gesprächsanalyse
- Selbstreflexion
- Supervision

MASSNAHMEN

- Aktives Zuhören
- Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
- Ich-Botschaften
- Feedback-Kultur

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Beeinträchtigte verbale Kommunikation · E: sprachlicher Barriere/Aphasie · S: Patient kann Bedürfnisse nicht äußern
RESSOURCEN	Gestik vorhanden, Familie als Dolmetscher, Bildkarten verfügbar
PFLEGEZIEL	Patient kommuniziert 3 Grundbedürfnisse (Schmerz, Hunger, Toilette) mit Hilfsmitteln nach 48h
MASSNAHMEN	• Kommunikationsboard einsetzen (Bilder/Symbole) • Ja/Nein-Fragen stellen • Einfache kurze Sätze, langsam sprechen • Geduld: Patient nicht unterbrechen • Logopädie einbeziehen • Nonverbale Kommunikation bewusst einsetzen (Mimik, Gestik) • Angehörige als Kommunikationshelfer schulen
EVALUATION	Täglich Kommunikationserfolge dokumentieren

PSYCHOLOGIE FÜR PFLEGE
19 Stressbewältigung & Burnout ICD Z73

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Stressbewältigung & Burnout.“

Pflegeberufe haben hohes Burnout-Risiko. Burnout = emotionale Erschöpfung + Depersonalisation + reduzierte Leistungsfähigkeit. Prävention ist Kernaufgabe des Selbstmanagements.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Emotionale Erschöpfung
- Zynismus, Distanzierung
- Leistungsabfall
- Schlafstörungen
- Psychosomatische Beschwerden
- Innere Kündigung

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“
INSTRUMENTE

- Maslach Burnout Inventory (MBI)
- Selbstreflexion
- Supervision
- Betriebsärztliche Beratung

MASSNAHMEN

- Ressourcenaktivierung
- Work-Life-Balance
- Supervision
- Psychotherapie
- Stressmanagement-Techniken

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Risiko Burnout · E: chronischer Arbeitsbelastung und unzureichender Erholung · S: MBI-Score erhöht
RESSOURCEN	Hohe Berufsmotivation, Kollegiales Team, Sport als Ausgleich
PFLEGEZIEL	Mitarbeiter benennt 3 persönliche Stressbewältigungsstrategien und nutzt sie regelmäßig
MASSNAHMEN	• Supervision regelmäßig anbieten • Dienstplanung: ausreichend Erholungszeiten • Ressourcen stärken: was gibt Energie? • Grenzen setzen: Nein sagen lernen • Progressive Muskelrelaxation (PMR) anleiten • Kollegiale Fallberatung etablieren
EVALUATION	Nach 4 Wochen: MBI-Score, subjektives Wohlbefinden

PSYCHOLOGIE FÜR PFLEGE

20 Motivationstheorien

Prüfer: „Erklären Sie kurz: Motivationstheorien.“

Theorien zur Erklärung menschlichen Verhaltens und Antriebe. In der Pflege relevant für Patientenedukation, Compliance-Förderung und Teamführung.

Prüfer: „Worauf achten Sie, welche Probleme können auftreten?“

- Mangelnde Compliance
- Non-Adhärenz
- Motivationsprobleme im Team

Prüfer: „Welche Maßnahmen und Instrumente kennen Sie?“

INSTRUMENTE

- Motivationsanalyse
- Gespräch
- Zielvereinbarung

MASSNAHMEN

- Motivierende Gesprächsführung
- Ressourcenorientierung
- Zielvereinbarung

Prüfer: „Formulieren Sie eine Pflegeplanung.“

PFLEGEPROBLEM	P: Unwirksames Gesundheitsverhalten · E: geringe Motivation, fehlendes Krankheitsverständnis · S: unregelmäßige Medikamenteneinnahme, Termine werden nicht wahrgenommen
RESSOURCEN	Gesprächsbereit, Wunsch nach mehr Selbstständigkeit, Partnerin unterstützt
PFLEGEZIEL	Patient nennt bis zur Entlassung zwei persönliche Gründe für die Therapie und nimmt seine Medikamente an 7 von 7 Tagen selbstständig ein
MASSNAHMEN	• Motivierende Gesprächsführung (offene Fragen, aktives Zuhören, Zusammenfassen) • Ziele gemeinsam vereinbaren, kleine Schritte • Fortschritte positiv verstärken • Wochendosett und Einnahmeplan einführen • Angehörige einbeziehen
EVALUATION	Täglich Einnahme kontrollieren, Gespräch zur Motivation alle 2 Tage



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de